

Question 1

Un jeune patient, connu pour plusieurs épisodes de sinusite aiguë, a été mis une nouvelle fois sous antibiotiques (amoxicilline + clavulanate) par son médecin traitant, et sous ibuprofène pour un léger mal de tête.

Dès la première dose, il voit apparaître, une heure plus tard, des lésions cutanées, érythémateuses, légèrement prurigineuses, sur tout le corps. Peu inquiet, il reprend un comprimé d'antibiotique en fin de journée. Dans la soirée, il se présente aux urgences pour urticaire généralisée, angioedème de la face et du fond de gorge, dysphagie et dyspnée.

Quelle attitude adopter en telle situation ?

- A. Adresser le patient pour la réalisation de tests épicutanés (patch tests)
- B. Recommander pragmatiquement l'éviction définitive des bêtalactamines, vu la haute probabilité que ce médicament soit en cause
- C. Pratiquer des tests intradermiques (IDR) pour les pénicillines et les céphalosporines
- D. Recommander l'éviction définitive de l'amoxicilline et de l'ibuprofène
- E. Effectuer des tests cutanés aux macrolides (clarithromycine) afin de s'assurer que le patient les tolère comme antibiotiques alternatifs

Question 2

Un footballeur du Lausanne-Sport est admis en Orthopédie pour le retrait de plaques d'ostéosynthèse, en AG. Comme induction, il reçoit du fentanyl, du disoprivan et du cisatracurium. Juste avant l'induction, il reçoit une prophylaxie antibiotique de cefuroxime iv. Quatre minutes plus tard, avant même que le chirurgien n'entre en action, le patient présente brutalement une hypotension artérielle à 70/40 mmHg, une tachycardie à 147/minute, sans autre symptôme. L'administration d'adrénaline iv et d'une expansion volumique permettent de corriger rapidement la situation, et de procéder finalement à l'intervention sans autre problème.

Quelle attitude adopter en telle situation ?

- A. Adresser le patient à l'allergologue pour tester les curares
- B. Adresser le patient à l'allergologue pour tester les céphalosporines
- C. Adresser le patient à l'allergologue pour tester le latex
- D. Réaliser les points 1 à 3
- E. Ne rien faire du tout, car une hypotension est banale au cours de l'induction

Question 3

Vous recevez en urgence un patient de 23 ans, sans antécédent particulier. Il présente depuis une semaine un état subfébrile (entre 37.5 et 38.5°C). Il vous décrit une toux nouvelle, plutôt sèche depuis 3 ou 4 jours, avec parfois des filets de sang. Il a aussi remarqué une tuméfaction symétrique des grosses articulations et des œdèmes des chevilles.

L'EG du patient est conservé, sa T° est de 38.1°C. La FSC est normale, hormis une hémoglobine à 95 g/l (N: >133), et la créatinine sérique est à 135 umol/l (N: <106)

Que prévoyez-vous de faire en telle situation ?

- A. Le plus probable chez ce jeune adulte est une pneumonie atypique, communautaire; vous lui prescrivez un antibiotique et l'adrezsez au médecin traitant pour la suite du ttt
- B. L'association d'un EF, d'une toux et de douleurs articulaires parlent pour une virose. Vous prescrivez des fébrifuges sous la forme d'AINS
- C. L'EG du patient étant bon, seule une RX de poumon s'impose comme examen complémentaire pour s'assurer de l'absence d'une pneumonie
- D. Le patient étant à l'hôpital, vous profitez d'ajouter à la RX du poumon d'autres examens, comme le sédiment urinaire et un panel d'auto-anticorps
- E. La situation n'étant pas claire, vous hospitalisez le patient pour ttt antibiotique et arrangez à ce que les immunologues passent le voir le lendemain

Question 4

Une patiente de 78 ans en BSH est accompagnée aux urgences par sa fille. Connue seulement pour un diabète non insulino-requérant, cette dame présente une asthénie marquée depuis deux semaines, peut-être de la fièvre, mais surtout des céphalées nouvelles, frontales, rebelles au traitement de paracétamol, ainsi qu'une claudication de la mâchoire.

Que peut-on prévoir pour aider cette dame ?

- A. Lui prescrire sans attendre de la Prednisone, et la revoir dans un mois pour juger de l'effet
- B. Faire un CT-scan cérébral en vue d'une PL pour exclure une méningite tuberculeuse chez cette patiente âgée
- C. Adresser la patiente au chirurgien pour biopsie de l'artère temporale, et lui donner un rendez-vous une fois le résultat histologique obtenu
- D. Lui prescrire sans attendre de la Prednisone, la revoir dans 3 ou 4 semaines pour juger de l'effet, et faire alors une biopsie de l'artère temporale s'il n'y a pas d'amélioration
- E. Lui prescrire sans attendre de la Prednisone, demander un ultrason des artères temporales en urgence et prévoir le cas échéant une biopsie de l'artère temporale

Question 5

Alors que vous venez de vous installer dans votre nouveau cabinet, un gynécologue vous demande de pratiquer un bilan sanguin chez sa patiente de 60 ans, qui doit subir une hystérectomie pour myomes utérins multiples, symptomatiques. Parmi les résultats, vous découvrez des anticorps anti-HCV positifs, alors que les tests hépatiques sont parfaitement normaux.

Que choisissez-vous de faire en pareille situation?

- A. Suspectant que ce soit un test faussement positif, vous banalisez la situation
- B. Suspectant que ce soit un test faussement positif, vous décidez de renvoyer un échantillon de sang au laboratoire pour effectuer une virémie
- C. Devant ce résultat, vous appelez la patiente pour l'informer de la découverte, chez elle, d'une hépatite C chronique
- D. Vous appelez votre collègue gastroentérologue pour prévoir un US hépatique et une PBF
- E. Vous téléphonez à la patiente pour l'informer que vous allez demander au laboratoire d'ajouter un test de dépistage HIV sur l'échantillon

Question 6

Une jeune femme de 37 ans, que vous suivez régulièrement pour des sinusites maxillaires à répétition, est hospitalisée pour une méningite à méningocoques. On vous appelle pour vous donner le résultat d'un dosage des IgG totales pratiqué en urgence et qui s'élève à 4.98 g/l (N: 7.00-14.00).

Qu'êtes-vous amené à en conclure ?

- A. La patiente présente une immunodéficiência humorale et doit donc être substituée par immunoglobulines parentérales dans les plus brefs délais
- B. Un dosage pratiqué en phase infectieuse peut être faussement bas et doit être répété quelques semaines plus tard
- C. Il faut suspecter une asplénie chez cette patiente
- D. Un épisode unique de méningite à méningocoques ne requiert aucune investigation complémentaire
- E. Les propositions 1 à 4 sont fausses

Question 7

Un patient d'une 30aine d'années se présente à votre consultation pour des douleurs abdominales fluctuantes depuis 4 ou 5 jours, accompagnées de diarrhées modérées, de frissons occasionnels, et avec des conjonctives légèrement teintées de jaune. Le bilan que vous demandez révèle les sérologies suivantes :

anti-HAV totaux positifs, anti-HAV IgM négatifs, HBsAg positifs, anti-HBc totaux positifs, anti-HBc IgM positifs, anti-HBs négatifs, anti-HBe négatifs, anti-HCV positifs, HCV-RNA négatif, HIV-RNA négatif.

Que pouvez-vous en conclure ?

- A. Le patient présente une hépatite A aiguë
- B. Le patient présente une hépatite B aiguë
- C. Le patient présente une co-infection HBV/HCV
- D. Le patient présente une co-infection HAV/HCV
- E. Le patient présente une hépatopathie d'origine non-virale

Question 8

Un patient diabétique de 80 ans se présente aux urgences le matin suite à l'apparition d'une tuméfaction de la langue la veille au soir, avec dysarthrie croissante et légère gêne respiratoire. Il avait présenté il y a quelques semaines un épisode de tuméfaction de la lèvre supérieure à droite, mais comme la symptomatologie avait régressé en 48h, il ne s'était pas plus inquiété.

Quelle investigation vous semble la plus pertinente dans cette situation ?

1. Dosage de la tryptase sérique
2. Enquêter sur la présence d'inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) ou de gliptines (inhibiteurs DPP4) dans le traitement du patient
3. Recherche d'IgE spécifiques aux aliments les plus souvent responsable d'allergie alimentaire chez l'adulte
4. CT-scan cervical afin d'établir l'étendue de l'oedème
5. Dosage du C1-inhibiteur pondéral et fonctionnel

Question 9

Laquelle des réponses suivantes est fausse (1 possibilité, entourez la réponse fausse d'un cercle)

Parmi les facteurs de risques pour une réaction d'hypersensibilité immédiate au produit de contraste iodé (réaction allergique survenant dans l'heure qui suit l'administration du produit) on compte:

1. L'anaphylaxie a des aliments (allergie à la cacahuète p.ex.)
2. L'asthme bronchique
3. Une réaction préalable d'hypersensibilité immédiate au produit de contraste iodé
4. Une allergie au iode contenu dans les désinfectants (Bétadine® p.ex.)
5. L'utilisation d'un produit de contraste hyper-osmolaire

Question 10

Une patiente de 28 ans présente une photosensibilité nouvelle avec des lésions érythémateuses infiltrées polycycliques sur les bras et le décolleté, des arthralgies inflammatoires prédominant aux mains et poignets (2 épisodes d'une durée de 1-2 semaines sur les deux dernières années et ayant répondu à des traitements d'AINS). Elle n'a actuellement pas de plainte articulaire.

Le labo montre: VS 16 mm/h (N<10), leucocytes 3.6 G/L (N4-12), reste de la FS sp. créatinine sp - sédiment sp. FAN 1/320 homogènes (N<1/80), Anti-dsDNA 300 IU/ml (EIA, N<200), anti-nucléoprotéines (ENA) dépistage positif, avec spécificité anti-U1-RNP à 25 U (N<20); complément C3 et C4 normal.

Quelle pathologie correspond le mieux à la présentation clinique ?

1. Syndrome de Sjögren
2. Polyarthrite rhumatoïde
3. Syndrome de Henoch-Schönlein
4. Lupus érythémateux systémique
5. Arthrite réactionnelle

Question 11

Vous diagnostiquez un lupus érythémateux systémique débutant chez une patiente de 28 ans avec photosensibilité nouvelle et lésions infiltrées des bras et du décolleté, arthralgies inflammatoires intermittente, asthénie, leucopénie et profil d'auto-anticorps compatible (anti-dsDNA, anti-U1-RNP).

Les lésions cutanées et la leucopénie persistent actuellement et elle se plaint d'une asthénie. Elle ne présente pas de signes d'atteinte viscérale.

Quel traitement initial proposez vous ?

- A. Hydroxychloroquine (Plaquenil)
- B. Thalidomide
- C. Rituximab (anticorps monoclonal anti-CD20)
- D. Belimumab (anticorps monoclonal anti-Blys)
- E. Méthotrexate

Question 12

Un homme d'une cinquantaine d'année se présente à votre consultation avec une rhino-sinusite chronique avec polypose. Vous recherchez des éléments pour un syndrome de Widal.

Parmi les éléments suivants lequel n'est pas suggestif d'un syndrome de Widal:

- A. Perte de l'odorat
- B. Intolérance à l'alcool
- C. Obésité
- D. Intolérance aux inhibiteurs non-sélectifs de la cyclooxygénase (COX)
- E. Asthme bronchique persistant

Question 13

Une femme de 45 ans présente depuis 3 ans une polypose nasale et asthme bronchique persistant. Elle a développé une crise d'asthme sévère suite à la prise d'un sachet d'Aspégic. Elle présente une éosinophilie sanguine qui oscille entre 500-1000/mm³. Le contrôle sous corticostéroïdes topiques est insuffisant

Parmi les mesures suivantes, laquelle n'a pas fait preuve d'efficacité dans le contexte de syndrome de Widal:

- A. Traitement par corticostéroïdes systémiques
- B. Régime alimentaire pauvre en salicylates
- C. Recours aux inhibiteurs sélectifs de la COX-2 en cas de besoin d'AINS
- D. Ajout d'un inhibiteur des leukotriènes (montelukast)
- E. Ajout d'un inhibiteur de l'IL-5 (anticorps monoclonal anti-IL5 ou IL-5R)

Question 14

Un jeune homme vivant en région Lausannoise atteint d'une rhino-conjonctivite saisonnière en avril depuis l'enfance rapporte depuis quelque temps un prurit buccal à consommation de pommes et de kiwis.

Quel est le pollen le plus probablement impliqué dans ce syndrome d'allergie croisée ?

- A. Graminées
- B. Frêne
- C. Bouleau
- D. Noisetier
- E. Ambroisie

Question 15

Une patiente de 30 ans atteinte d'un lupus érythémateux systémique à expression cutanée (photosensibilité, rash zones photo-exposées), articulaire (quelques épisodes d'arthrites) et hématologique (leucopénie modérée), traitée par hydroxychloroquine (Plaquenil), arrêté il y a 6 mois. Reprise des arthralgies, traitées par AINS. Elle a débuté une pilule oestroprogestative. Développe des oedèmes des MI. Poids + 3kg en 3 semaines.

Au status BEG, OMI modérés, Gaensslen + sans autres particularités.

Labo: VS 23 mm/h (N<10) - CRP 4 (N<5), Lc 3.3 G/l (N>4), Tc 95 G/l (N 150-300) créatinine ↑ 110 mmol/L (N<110, précédemment 75); sédiment 110 Ec/champ; protéines urines 1.4 g/L; C3 et C4 ↓; FAN 1/640 h; anti-dsDNA 350 IU/ml (N<200)

Quelle attitude proposez-vous ?

- A. arrêter AINS et pilule à base d'oestrogènes
- B. arrêter AINS et débuter un diurétique
- C. débuter Prednisone 20mg/jour
- D. adapter le traitement selon la biopsie rénale
- E. la perturbation du sédiment urinaire justifie l'administration de méthylprednisolone pulsée (Solumédrol) et cyclophosphamide (Endoxan) i/v

Question 16

Une patiente de 56 ans développe une lésions très douloureuse de la pulpe de l'index droit qui laisse soudainement s'écouler un liquide blanchâtre avant de cicatriser spontanément. Depuis 3 ans elle souffre d'un syndrome de Raynaud. Elle indique une tendance aux fausses-routes et est gênée par l'apparition de télangiectasies du visage.



Les anticorps anti-nucléaires reviennent fortement positifs.

Laquelle de maladies suivantes correspond le mieux au tableau présenté:

- A. Maladie de Behçet
- B. Sclérose systémique
- C. Dermatomyosite
- D. Polyarthrite rhumatoïdes
- E. Lupus érythémateux systémique

Question 17

Une patiente de 56 ans présente un syndrome de Raynaud d'apparition tardive, des doigts boudinés et un reflux gastro-oesophagien. Les anticorps anti-centromères sont positifs.

Lequel des examens suivants est à demander en priorité pour confirmer le diagnostic ?

- A. Capillaroscopie
- B. Mesure de la calciurie de 24 h
- C. CT-scan pulmonaire à coupes fines
- D. Manométrie oesophagienne
- E. Echocardiographie

Question 18

Un patient de 28 ans présente de février à juillet une rhino-conjonctivite et un asthme léger/modéré persistant ($FEV_1 > 80\%$ du prédit hors traitement, variabilité du PEF 20-30%). Le cp d'antihistaminique (cetirizine 10mg) ne suffit plus et le patient ressent des symptômes d'asthme plus de 4 jours par semaine, qu'il traite avec 1 push de bêta-2-mimétique à courte durée d'action (salmeterol) à la demande.

Il vous demande des conseils quant à son traitement optimal.

Laquelle des affirmation suivantes est correcte ?

- A. Renforcer le traitement par corticostéroïdes topiques et bêta-2-mimétiques à longue durée d'action (budésonide-formotérol) à la demande
- B. Débuter une désensibilisation sublinguale aux graminées
- C. Changer le traitement de bêta-2-mimétique à courte durée d'action pour un bêta-2-mimétique à longue durée d'action
- D. Renforcer mesures d'éviction des allergènes, soit limiter les activités à l'extérieur et se laver les cheveux tous les soirs en saison pollinique
- E. Doubler la dose d'anti-histaminique (cetirizine 10mg matin et soir) et de bêta-2-mimétique à courte durée d'action (2 push)

Question 19

Un asthmatique de 30 ans, allergique aux pollens de graminées, perd connaissance en gravissant une côte à vélo. Il n'avait pas de symptômes d'asthme ce jour là ni les jours précédents, alors qu'il avait déjà fait la même route à vélo. Il indique avoir présenté 5' avant sa chute des picotements dans le pli de l'aîne. Il avait mangé 3h avant le malaise un petit-déjeuner composé de croissants à la farine de blé et seigle, beurre-confiture et bu du café au lait.

Laquelle des affirmation suivantes n'est pas correcte ?

- A. Il faut examiner le patient à la recherche d'une piqûre de guêpe ou d'abeille
- B. Il faut suspecter une anaphylaxie à l'effort dépendant d'un aliment
- C. Il faut doser les IgE spécifiques aux pollens de seigle
- D. Il faut enquêter sur la prise d'éventuels médicaments
- E. Il faut doser la tryptase sérique

Question 20

Une patiente de 50 ans présente une asthénie progressive, état subfébrile (T 37.4-38.0 °C), perte de poids de 6 kg sur 2 mois et une dyspnée d'effort croissante. Elle est connue pour une rhinosinusite et un asthme.

Le labo montre une anémie normochrome microcytaire avec Hb à 100g/l (N>120 g/l), une leucocytose à 13 G/l, avec 25% d'éosinophiles (3250/mm³; N<500), CRP 79 mg/l, fonction rénale et tests hépatiques avec transaminases à 2 x la norme.

Parmi les pathologies suivantes, laquelle **ne fait pas partie** du diagnostic différentiel:

- A. Infestation par un parasite
- B. Granulomatose eosinophilique avec polyangéite (Churg & Strauss)
- C. Pathologie tumorale
- D. Hypersensibilité médicamenteuse
- E. Exacerbation asthmatique